| 气滞证标准征求专家意见反馈汇总 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分 | 章条编号 | 意见或建议 | 理由 | 采纳与否 | 理由 |
| 编制说明 | 说明·6 | “职称分别未教授、主任医师、副主任医师。”中“未”改为“为” | 错字 | 采纳 | |
| 编制说明 | 说明·6 | 未教授改为：为教授 | 错别字 | 采纳 | |
| 编制说明 | 附件2 | 明确题目气滞证诊断标准 | 表述不清 | 不采纳 | 已明确。 |
| 编制说明 | 附件2 | 4个亚型证 | 个人建议更换为证候的4个亚型 | 不采纳 | 本标准建立的是一个整体的气滞证，亚型证可在本标准建立后，将考虑建立4个亚型证。 |
| 编制说明 | 附件2第28页 | 肺气郁滞证候文献系统评价结论 | 肺气郁滞证输入重复 | 采纳 | |
| 编制说明 | 编制说明<br>1.1.1中文数据库检索式<br>①肝郁气滞证 | 4）#1 AND#2 AND#3。<br>建议修改为：<br>4）#1 OR #2 AND#3。 | #1，#2均为疾病，是“或”的关系 | 采纳 | |
| 编制说明 | 编制说明1.1.2英文数据库检索式<br>①肝郁气滞证 | 4）#1 AND#2 AND#3。<br>建议修改为：<br>4）#1 OR #2 AND#3。 | #1，#2均为疾病，是“或”的关系 | 采纳 | |
| 编制说明 | 编制说明<br>表11　肺气郁滞证症状归类的频数分析结果 | | 症状描述的频数均重复出现，删除1列 | 采纳 | |
| 编制说明 | | 气滞证诊断标准编制说明详细论述了研制思路和工作路径，团队协作分工体现了深厚的理论素养和扎实的临床实践能力，通过多中心协作，运用文献系统评价、德尔菲法、层次分析法、专家访谈、诊断性试验等先进方法，获得了证据充分的合理结论，最终确立了气滞证诊断条目及其权重，修订了气滞证相关诊断标准，为气滞证的临床诊疗和科学研究提供了可操作性强的技术指导 | | 采纳 | |
| | | | | | |
| 征求意见稿 | 附件2 | 同意气滞证的诊断标准。非常有意义。这是中诊研究最正确的方向。<br>但有个问题，这个表可能只适用于气滞证的诊断。<br>建议若是进一步直接能把肝郁气滞证、胃肠气滞证、心脉气滞证、肺气郁滞证在此表中明确诊断 | 因为临床特别是医院目前写病历诊断最落地的不是病性辨证-气滞证，而是脏腑辨证-肝郁气滞证等。 | 不采纳 | 本标准整体的气滞证诊断标准，脏腑辨证肝郁气滞证等包含在其中。本标准发布后，将考虑进一步细化脏腑辨证的工作。 |
| 征求意见稿 | 附件2 | 建议此标准制定好后，直接做个软件，规则写进软件，用这个软件即可判断证型。推广时可用，还是个成果。有机会我可以参与，另外肝郁气滞证型的标准制定我参与。 | 软件用起来比纸质量表更好用，下一步数据更好统计验证。更适用。 | 采纳 | 此观点非常赞同，标准成立后将进一步深化研究。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征求意见稿 | 附件2 | 气滞进一步发展会形成气滞血瘀、.....建议增加气机闭阻 | 我认为气滞与气闭在程度和表现上还是有所区分的，气滞发展转归应该包括气闭 | 不采纳 | 本标准基于气滞证为始发证上建立的，不涉及其他的演变证候。标准成立后将进一步进行变证的研究。 |
| 征求意见稿 | 标题翻译、引言、附录A | 整体上，标准制定团队系统回顾了气滞证的描述和规范，结合最新研究进展，在语言描述方面进一步简练精准，具有很强的可操作性，为气滞证在临床各科疾病的规范应用提供了明确的依据。 | 在文字描述上，存在极少量可优化的细节，详见修订模式。“stagnation”首字母大写；“并为其始发证和基本证，常伴随疾病始终，但诊断标准缺如，”改为“可作为始发证和基本证，常伴随疾病始终，但诊断标准阙如”；“附录A”是否需要统一标点的半角和全角？ | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 引言 | 多见于许多重大疾病和慢性疾病 | 多见于一些。。。 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 引言 | 引言：为避免个人因素对辨证的干扰，提高临床诊疗和临床科研辨证的准确性和一致性，结合国内外最新证候及相关术语研究进展，特制定本标准，指导临床与科研气滞证辨证的准确性和规范性。<br>建议改为：为了提高中医临床辨证的准确性和一致性，结合国内外最新证候及相关术语研究进展，特制定本标准，指导临床疾病气滞证辨证的 | 1.对辨证的干扰原因很多，比如辨证标准不一样，因此建议去掉个人因素，<br>2.因为临床科研实际属于临床工作的一部分，所以建议去掉临床科研 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 引言 | 引言：本文件基于中医气滞证理论的气滞（为核心病机）和特征性舌脉象<br>建议改为：本文件基于文献研究、专家调查及中医病因病机 | 1.由于该标准的制定过程是从文献、专家调查和病因病机3个方面进行的，不是仅仅从核心病机和舌脉象入手<br>2.舌脉象只是症状的一部分 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 引言 | 本文件基于中医气滞证理论的气滞（为核心病机）和特征性舌脉象 | 表述不清 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 引言 | 特制定本标准，指导临床与科研气滞证辨证的准确性和规范性。<br>建议修改为：特制定本标准，指导临床与科研工作中气滞证辨证的准确性和规范性。 | 表述不清 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 1 | 诊断依据和诊断标准 | 诊断标准和依据 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 2 | 规范性引用文件，这部分应该是相应的标准，有文件号 | | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 术语和定义 | 3.1气滞证指人体某一部位或某一脏腑、经络的气机郁滞，运行不畅所出现的证候。改为：气滞证指人体某一脏腑、经络或某一部位的气机郁滞，运行不畅所出现的证候。 | 脏腑经络放前面 | 采纳 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征求意见稿 | 术语和定义 | 气滞证指人体某一部位或某一脏腑、经络的气机郁滞所出现的证候。删除“运行不畅” | 气机即气的运行，原表述冗繁。 | 不采纳 | 气的功能是运动的，主要表现形式以升降出入为主，气机郁滞则会出现运行不畅。因此，需要纳入“运行不畅”。 |
| 征求意见稿 | 前言 | 按姓氏笔划排序改为按姓氏笔画排序 | 此处用词错误应改为按姓氏笔画排序 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 范围 | 本标准适用于全国各级医疗机构及科研院所专业人员对气滞证的临床诊断 | 临床诊断？ | 不采纳 | 修改：本标准适用于全国各级医疗机构及教学科研院所专业人员对气滞证的诊断。 |
| 征求意见稿 | 3　术语和定义<br>下列术语和定义适用于本标准。 | 术语定义是否都包含气滞证诊断依据表所列举条目内容 | 解释说明可能显得更加丰富、充实 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.1 | 去除“气郁证” | 气滞为生理层面，郁为精神心理层面。 | 不采纳 | 《GB/T 16751.2-2021 中医证候诊疗术语·证候》有说明。 |
| 征求意见稿 | 3.1 | “气滞进一步发展会形成气滞血瘀”建议改为“气滞证进一步发展会形成气滞血瘀” | 前后文词性一致 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.1 | “咽部异物感、矢气、嗳气、纳呆、心悸、气短、气喘、咳嗽”可加“或” | “咽部异物感、矢气、嗳气、纳呆、心悸、气短、气喘、咳嗽”不是气滞证的必然症状和特异症状，而是病位症状。 | 不采纳 | 气滞证表格的兼证条目（脏腑辨证）是病位特征，这些条目本身是“或”的关系。 |
| 征求意见稿 | 3.1 | 气滞证 qi stagnation syndrome/pattern<br>气滞证指人体某一部位或某一脏腑、经络的气机郁滞，运行不畅所出现的证候<br>:建议修改为：气滞证指人体某一脏腑、经络气机郁滞、运行不畅所出现某一部位胀闷窜痛等为主要表现的证候 | 脏腑、经络气机郁滞：这是病因病机<br>某一部位胀闷窜痛：这是症状 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.2 | “疼痛部位走窜不定，且伴有胀感或郁闷不舒感。”建议改为“或” | 窜痛和胀满可不同时出现 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.3 | 情志抑郁是否要细化下时间病程？ | 偶有的抑郁情绪也较常见 | 不采纳 | 偶尔的情绪异常为正常人的表现。 |
| 征求意见稿 | 3.4 | 急躁易怒解释为“心情急躁，容易发怒。”建议修改为“性格急躁，容易发怒。” | 急躁是指性格，而非心情。二者有差别。 | 不采纳 | 急躁易怒是情绪方面症状，改为“情绪急躁，容易发怒”。 |
| 征求意见稿 | 3.7 | 核对该条文“咽部异物感：自觉咽部有异物梗阻感，吞之不下，吐之不出。” | 常见描述为咯/咳之不出，咽之不下，建议核对 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.8 | 增加“经间期出血” | 根据中医妇科学 | 不采纳 | 依据中医妇科学，月经不调与经间期出血属于两个范畴。 |
| 征求意见稿 | 3.8 | 月经不调，期、量、色、质的异常，应该涉及色质的描述以及闭经的情况 | 应补充气滞所致月经的色、质变化，另，临床很多气滞证可以出现闭经，不仅是先期后期等 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.6 | “平常呼吸之后有延长和间歇的深长呼吸。”定义不清晰，建议参考教材。 | 太息确实内涵较混乱，但此处所引不是常用的 | 采纳 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征求意见稿 | 3.6 | 太息的概念建议参考十四五规划教材《中医诊断学》 | | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.11 | 纳呆：进食量的欲望减退，改：进食欲望或/和进食量减退 | 原语句不通、不正确。另应该分开食欲与食量的概念 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.11 | 去掉“症状”二字，或移至结尾处 | 和其他词语解释统一 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.12 | “便次减少，便质干燥，或”不一定都干燥，建议删去 | 便秘：指大便秘结不通，排出困难，便次减少，或排便时间延长，欲便而艰涩不畅者，亦称“大便难”。 | 不采纳 | 专家推荐的是十二五规划教材，此条术语的释义基于最新的十四五规划教材中医诊断学。 |
| 征求意见稿 | 3.14 | 肠蠕动亢进而漉漉有声的表现，建议加上部位，腹部漉漉 | 需要明确部位。另，此症应该更像是饮停胃肠、水走肠间的代表性表现，需斟酌 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.15 | “连续不断的症状”改为“表现” | 是体征不是症状 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.17 | 呕吐，后面的有物无声，有声无物之分感觉可以删去。 | 从临床诊治及病机分析角度，感觉再来区分呕与吐及干呕之类没有太大必要 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.20 | 气短 | 气滞证的气短感觉需要注释下和气虚证气短鉴别开来 | 采纳 | 已加入说明，“常兼有呼吸声粗，或胸部窒闷，或胸腹胀满等”。 |
| 征求意见稿 | 3.20和3.25 | 气短与气促的概念有重叠交叉现象，难以区分。气短：呼吸气急短促，气促，呼吸急促。都包括急促的特征。感觉如果做为两个症状概念，应该有一定的区分性。 | 个人认为，气短更强调一种自己的感觉，气短不足以息，未必一定有呼吸急促之象。建议更改第一句 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.22 | 憋气：删除 | 常用：胸闷或胸部憋闷 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.21 | 去掉“症状”二字，或移至结尾处 | 同上 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.21 | 是否需细化说明包含早醒？ | | 不采纳 | 术语解释中的“睡而易醒，难以复睡”为早醒的描述。 |
| 征求意见稿 | 3.23 | “气喘”是否合适 | “气喘”属于气逆 | 不采纳 | 气喘可因气机阻滞，肺失宣降所致。 |
| 征求意见稿 | 3.23 | “气喘”建议改为“喘”或“喘促” | 很少用“气喘”一词 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.23 | 气喘，改为喘 | 常用“喘” | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.23 | 去掉“短促” | 临床气喘不一定会短促，有时也会出现深长呼吸 | 不采纳 | 本标准立足最新的十四五规划教材而来。 |
| 征求意见稿 | 3.24 | 上文呕吐分别将二字解释，此处咳与嗽未分别解释，建议前后统一 | 前后一致 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 3.30 | 薄白苔 thin, white coating<br>“舌苔薄白润泽，颗粒均匀，薄薄铺于舌面，揩之不去。”建议修改为“舌苔薄薄一层分布于舌面，透过舌苔可以看到舌体，揩之不去。” | 1.舌苔的“薄与厚”关键区别在于“见底与不见底”<br>2.薄白苔有润、干与滑之分，病邪的性质与病证的轻浅不同。<br>3.气滞证可见薄白润苔、薄白干苔 | 采纳 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征求意见稿 | 3.32 | 弦脉 string pulse<br>“脉势紧张，端直以长，如按琴弦。”建议修改为“端直以长，如按琴弦。” | 1.脉势紧张、脉势较强、脉体较硬等都是后世对弦脉“如按琴弦”的解释，脉势是脉象要素之一，五版中医诊断是脉象五要素，六版中医诊断学有脉象八要素。脉势建议不与“端直以长，如按琴弦”并列 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4介绍 | “运用文献系统评价、德尔菲法和层次分析法专家调查”增加标点符号“运用文献系统评价、德尔菲法和层次分析法，专家调查、” | 漏了标点符号 | 不采纳 | 都是方法学，因此采用分号并列。 |
| 征求意见稿 | 4共性条目 | 共性条目1.建议将胀闷、胀痛分为两个条目 | 理由同前，临床有仅胀或闷而不痛的。 | 不采纳 | 条目解释用的“或”连接的。 |
| 征求意见稿 | 4共性条目 | 胀满(闷)或胀痛或窜痛条目下的概念：身体某些部位出现疼痛，疼痛部位走窜不定，且伴有胀感或郁闷不舒感。建议加上仅有胀感或郁闷不舒感，另，建议写明或是加括号备注常见的部位，如头、咽喉、胸胁、乳房、少腹、阴部等 | 气滞证很多是没有明显疼痛的，故把痛和胀合在一起，连词用“且”不合适，应该有只胀或闷不痛的。 | 部分采纳 | 1.采纳。添加部位的描述。<br>2.不采纳。根据文献数据表明，疼痛的表现也有体现。临床上是有程度上的差异，轻型气机阻滞以胀满或胀闷为主，重型气机阻滞可出现疼痛感 |
| 征求意见稿 | 4共性条目 | 共性症状2：遇情志不遂时易诱发或加重：建议修改为：遇情志不遂时易诱发或加重，常随心情愉悦、嗳气、矢气等而减轻 | 既然有加重的原因，也应该有减轻的因素 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4共性条目 | 1. 胀满(闷)或胀痛或窜痛。<br>建议这样改：胀满(闷)或胀痛或窜痛<br>(备注：病位胸胁、少腹、乳房等明显，多见于肝郁气滞证；胸腹部等明显，多见于胃肠气滞证；心胸部等明显，多见于心脉气滞证；胸部等明显，多见于肺气郁滞证 ) | 这样写出来，不多余，而是能把肝郁气滞证、胃肠气滞证、心脉气滞证、肺气郁滞证，诊断的思路给明确点出来。因为将来要给其他人用的，这样用的人看到后使用时更明晰。 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4共性条目 | 共性条目的2 3　移至“兼证条目”“肝郁气滞证” | 肝郁可有情志表现，但生理的气滞是或然症状，如肢体经络不通有胀痛，但不一定有情志表现。胃肠气滞也少有情志表现。 | 部分采纳 | 1.采纳。共性条目3“情志抑郁”已移至“肝郁气滞证”中。<br>2.不采纳。根据十四五规划教材中医诊断学，气滞证表现含有共性条目2“遇情志不遂时易诱发或加重，随心情愉悦、嗳气、矢气等减轻”。 |
| 征求意见稿 | 4共性条目 | 共性条目2、3、4、5不应作为气滞证共性条目，当补充气滞证的共性条目内容 | 该4条属肝气郁结的条目 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4共性条目 | 太息、急躁易怒两项是否不适合放在共性症状中，应该放在肝郁气滞中，肝气滞中的嗳气、纳呆、便秘等应该放在胃肠中；气短仅放在心脉中，肺中仅放气促 | 胃肠及肺气滞应该可以不以太息及急躁易怒为特征。另外的理由见前述 | 采纳 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 1.肝郁气滞证：(4) 嗳气<br>(5) 纳呆<br>(6) 大便秘结<br>(7) 失眠<br>：这几个症状不一定属于肝郁气滞，只能说肝郁气滞可以进一步引起这些症状，属于继发性症状 | 继发性症状，其实脏腑的病位发生了改变，比如，肝郁气滞证，如果出现了(4) 嗳气 (5) 纳呆(6) 大便秘结，提示肝郁脾虚或肝胃不和 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 建议将(2) 月经不调（与男性无关）和(3) 痛经（与男性无关）合并为一条改为：妇女有月经不调、痛经，经前乳房胀痛。 | 皆为一类。（1）中医任何一证应该建立在具体脏腑之上，否则只能笼统谈发病机制如气机郁滞，故建议以具体脏腑的气滞证建立标准更具可操作性和临床指导意义；（2）中医的证采用累计赋分的方法不太合理，中医证候的诊断有时“舍脉求症”，有时“舍症求脉”，有时不必兼具“但见一症便是”；（3）本诊断表总分为16分，若以“临床见上述指标累计赋分＞16分者可诊断为气滞证”其阈值区间就没有了，也不符合逻辑；（4）基于中医基本理论和临床实践，气滞证诊断标准如采用主症和次症的的方法更具可操作性，这比加权累计赋分更加贴近临床实际。 | 采纳 | 1.本次制定的是总体的气滞证，包含具体各个脏腑气滞证，其中有主证、次证之分；<br>2.本研究是客观化主症+次症的诊断方法，分值大的是主症，分值低的是次症，例如，共性条目6分/项，兼证条目4分/项。同一条目中有多个症状或体征同时出现，仅按1项计分。<br>3.阈值的客观判定方式是：“共性条目1条+兼证条目2条+舌象或脉象1条”或“共性条目2条+兼证条目1条+舌象或脉象1条”，阈值范围[16-18]分，方便计数，选择低分16分作为阈值分。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 建议删除“失眠” | 失眠不是肝气郁滞权重症候，应是肝郁化火，即气滞的发展气郁化火证的权重症候。火扰神而不寐。 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 大便秘结：不应纳入 | 大便秘结在肝郁气滞证中不具特征 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 应该纳入：阳痿或疝气（男性） | 既然提到女性有痛经与月经不调，男性也应该有一定表现 | 不采纳 | 没有文献和前期专家的提议。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 建议将(6) 大便秘结这一条目删除 | 肝郁气滞的患者多为大便失调，大便秘结多为肝火旺者的临床表现 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 增加乳房胀（痛）（与男性无关） | 乳房为肝经循行所过，临床上肝郁气滞妇女，多见乳房胀（痛）。 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 增加面容憔悴 | 思虑过度，肝郁气滞导致失眠，患者多见面容憔悴。 | 不采纳 | 没有文献和前期专家的提议。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 增加手足不温 | 肝郁气滞，阳气内郁不达四末而见手足不温。 | 不采纳 | 手足不温重点不在气滞，在阳虚、寒凝中常见。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 肝郁气滞证症状积分在男女方面是否有所区别，积分总数一致 | 肝郁气滞证中两个女性特有症状（月经不调和痛经），男性没有相关症状。是否会引起积分在性别上的差异？ | 不采纳 | 本研究是客观化主症+次症的诊断方法，与积分在性别上无差异。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：1.肝郁气滞证 | 太息是否改为“善太息” | | 不采纳 | 根据十四五规划教材中医诊断学进行修改 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：2.胃肠气滞证 | 增加大便干结或大便次数减少或大便不畅。 | 胃肠道疾病一般都有大便异常。 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：2.胃肠气滞证 | 2 .胃肠气滞证中去除“(8) 嗳腐吞酸” | (8) 嗳腐吞酸主要反映饮食停滞，重点不在气滞，在伤食证中多见。 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：2.胃肠气滞证 | 建议“呕吐”修改为“胃脘痞满” | 作为胃肠气滞证，“胃脘痞满”比“呕吐”更常见 | 不采纳 | 胃脘痞满存在共性条目“胀满(闷)或胀痛或窜痛（头、咽喉、胸胁、胃脘、少腹等）”中。 |
| 编制说明 | 4兼证条目：2.胃肠气滞证 | 胃肠气滞证是否应该细化拆分出肝胃不和证 | 从常见症状名称归类及分析结果显示：如果患者出现其中的部分症状作为主要临床表现，多数临床诊断是肝胃不和证。 | 不采纳 | 本修订的胃肠气滞证，其中主要症状描述的是胃肠部气机运行不畅的表现，同时将肝脏部位出现的症状已删除。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：2.胃肠气滞证 | （1）兼证条目的分型是否更全面更细化一些，如肝脾气滞证、气滞胃脘证、小肠气滞证等； | （1）将兼证条目常见分型都列出来，有助于标准的规范使用，避免个人因素对辨证的干扰； | 不采纳 | 本研究是从常见的脏腑肝、胃肠、心、肺收集气滞证的诊断标准，本标准发布后，将考虑进一步细化的工作。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：3.心脉气滞证 | 增加手足不温 | 心脉气滞，行血不畅，不能载阳气达于四末而见手足不温。 | 不采纳 | 手足不温重点不在气滞，在阳虚、寒凝中常见。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：3.心脉气滞证 | 气滞证表现：心悸，建议改为惊悸 | 心悸范围太广，针对性不强，不是气滞的特征 | 不采纳 | 惊悸是因惊而导致悸动，不属于气滞证范畴。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：3.心脉气滞证 | 失眠：不应纳入 | 加入：胸痛或胸闷。失眠主要与心神失养有关 | 不采纳 | 根据文献研究及专家调查，失眠属于心脉气滞证的范畴。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：3.心脉气滞证和4.肺气郁滞证 | 3.心脉气滞证：(3) 失眠：失眠不一定是气滞<br>4.肺气郁滞证：(5) 咳痰<br>(6) 少痰<br>：这2个症状不属于气滞证 | 引起失眠的原因很多，不一定是气滞，所以，失眠最多属于次要性症状<br>咳痰说明是痰邪；少痰一般属于肺阴虚 | 部分采纳 | 1.失眠：根据文献研究及专家调查，失眠属于心脉气滞证的范畴；<br>2. 咳痰、少痰：已删。 |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：4.肺气郁滞证 | 咳痰，少痰：不应纳入 | 痰多少定性为痰，前面有咳嗽气喘 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4兼证条目：4.肺气郁滞证 | “少痰”可否改为“胸闷” | 3.26已有咳痰，肺气郁闭致胸部满闷，压迫感。 | 采纳 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征求意见稿 | 4兼证条目 | 兼证条目：建议每个脏腑气滞的诊断依据，首先是部位，其次是主要症状，最后是次要症状，主要症状和次要症状的得分应该不同 | 根据不同部位的症状才能诊断属于哪个脏腑，比如胸胁、少腹、乳房属于肝；有些次要症状，主要是其他脏腑引起的，其实并不是该脏的诊断依据 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4 舌象 | 舌象保留2 去除1 3 4 | 1.淡红舌 3.薄白苔 4.薄腻苔不反映气滞，易造成无效得分，干扰结论。 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4舌象 | “淡红舌”建议删除 | “淡红舌”是健康人的舌象，不应作为诊断标准 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4舌象 | “薄白苔”建议改为“白厚苔” | “薄白苔”是健康人的舌象，不应作为诊断标准，气滞多兼食滞、痰阻，白厚苔常见 | 不采纳 | 根据专家意见，此条目已删。 |
| 征求意见稿 | 4舌象 | 腻苔的概念为厚苔，薄腻苔的提法是否合适？ | | 不采纳 | 根据专家意见，此条目已删。 |
| 征求意见稿 | 4舌象 | 舌象：4.薄腻苔<br>属于次要性症状 | 腻苔属于湿邪痰饮食积 | 不采纳 | 根据专家意见，此条目已删。 |
| 征求意见稿 | 4脉象 | “沉弦脉”建议改为“沉脉” | 气滞日久多化热，未必一定有“弦脉” | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4脉象 | “弦滑脉”建议改为“滑脉” | 弦滑脉临床很难兼见 | 不采纳 | 根据专家意见，此条目已删。 |
| 征求意见稿 | 4脉象 | 脉象：2.沉弦脉<br>3.弦滑脉<br>4.弦细脉<br>：建议删掉 | 弦脉就是气滞；这几个脉属于相兼脉，可以去掉 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4脉象 | 脉象条目“1.弦脉 2.沉弦脉 3.弦滑脉 4.弦细脉”<br>建议修改为经典的“弦脉”。 | 既然共同点都是弦，就以“弦脉”为条目即可。否则，临床还可见弦涩脉，是否增加？ | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4 脉象 | 脉象中细分了4种脉象，建议合为一种“弦” | “弦”即气滞脉象，沉、滑、细是论虚实、邪气性质，不是气滞的脉象标准。 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4 脉象 | 脉象留“弦脉”，2 3 4建议去除 | 弦脉含盖了2.沉弦脉 3.弦滑脉 4.弦细脉，易造成勾选两项 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4 脉象 | 增加结脉 | 心脉气滞，心阳被抑，脉气阻滞而失于宣畅，故可见结脉。 | 不采纳 | 结脉在临床上不常见。 |
| 征求意见稿 | 4赋分 | 脉象赋份宜改为2分 | 主症分值应适当高于舌象脉象总分值为宜。 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 4赋分 | 各项目评分权重是否注明？ | 不同的分值所对应的标准，方便精准打分 | 采纳 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征求意见稿 | 4赋分 | （2）“注1：临床见上述指标累计赋分＞16分者可诊断为气滞证”，可否将此累计赋分改大，如≥20分？ | （2）满足共性条目至少2项12分，加舌色舌苔4分，加脉象4分，就有20分。 | 不采纳 | 1.本研究是客观化主症+次症的诊断方法，分值大的是主症，分值低的是次症，例如，共性条目6分/项，兼证条目4分/项。同一条目中有多个症状或体征同时出现，仅按1项计分。<br>2.阈值的客观判定方式是：“共性条目1条+兼证条目2条+舌象或脉象1条”或“共性条目2条+兼证条目1条+舌象或脉象1条”，阈值范围[16-18]分，方便计数，选择低分16分作为阈值分。 |
| | | | | | |
| 征求意见稿 | 附录A（资料性附录）P9 | 肝气郁结:精神抑郁,易怒,胁肋胀痛,痛无定处,胸闷不舒,善太息(喜叹长气):（将:改为，）或伴嗳气纳呆,脘腹胀痛,或咽中有物梗阻感,吞之不下,吐之不出 | 此处（，）可能更合适 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 附录 A（资料性附录）P10 | 2002年中医诊断学<br>气滞证：常见胸胁院（改为脘）腹等处胀闷疼痛,时轻时重,部位不固定,可为窜痛、攻痛，胀痛常随嗳气、肠鸣、矢气后减轻,或与情绪活动有关。脉弦,可无明显的舌象变化。 | 此处用词错误应改为常见胸胁脘腹等处胀闷疼痛，注意文中错别字问题 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 附录A （资料性附录）历年气滞证类中医辨证标准的相关部分 | 参考的相关资料是否足够全面 | 广泛搜集气滞证类的中医辨证标准资料和书籍，从中归纳整理总结可以使标准化量表内容更加系统、全面 | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 参考文献P15 | [22]邓铁涛.中医诊断学[M].人民卫生出版社，2007：415-428.<br>[39]何清湖.实用辨证手册[M].山西科学技术出版社，2015：31-328.<br>[55]李先涛，周旋，方格，等. 中医证候诊断量表研究现况[J]. 辽宁中医杂志,2020,47(01):18~21.<br>[56]周春兰，吉雪，吴艳妮. 患者赋权量表在慢性病患者中应用的信效度研究[J]. 中国全科医学,2016,19(34):4280~4284.<br>等等。应统一引用格式以及标点符号。 | 参考书籍引用格式或标点符号不正确，例如引用书籍需添加地名，应统一引用格式以及标点符号 | 采纳 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征求意见稿 | 参考文献 | [2]邓铁涛，欧明.临证先读[M].广东：广东科技出版社，1983：148-160.<br>建议修改为：<br>[2]邓铁涛，欧明.临证先读[M].广州：广东科技出版社，1983：148-160.<br><br>[5]成都中医诊断学.中医诊断学[M].四川：四川科技出版社，1990：206-248.<br>著者需确认<br>建议修改为：<br>成都：四川科技出版社<br>[8]张家锡. 中医诊断学[M]. 四川：四川科学技术出版社，1991：204-206.<br>建议修改为：<br>[8]张家锡. 中医诊断学[M]. 成都：四川科学技术出版社，1991：204-206.<br><br>[11]朱文锋，中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社，1997：322-359.<br>建议修改为：<br>[11]朱文锋. 中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社，1997：322-359.<br><br>[21]孙曾祺.实用中医辨证论治学[M].中国中医药出版社，2006：172-183.<br>建议修改为：<br>[21]孙曾祺.实用中医辨证论治学[M].北京：中国中医药出版社，2006：172-183.<br>[22]邓铁涛.中医诊断学[M].人民卫生出版社，2007：415-428.<br>建议修改为：<br>[22]邓铁涛.中医诊断学[M].北京：人民卫生出版社，2007：415-428.<br>[39]何清湖.实用辨证手册[M].山西科学技术出版社，2015：31-328.<br>建议修改为：<br>[39]何清湖.实用辨证手册[M].太原：山西科学技术出版社，2015：31-328.<br>[49]云秀花，贺景宏，王苏红等.实用中医内科学[M].上海：上海交通大学出版社，2017：187-202.<br>建议修改为：<br>[49]云秀花，贺景宏，王苏红，等.实用中医内科学[M].上 | 参考文献引用规范需符合国家标准：<br>信息与文献 参考文献著录规则（GB/T 7714—2015） | 采纳 | |
| 征求意见稿 | 参考文献 | 参考文献格式不统一，【63】-【67】【69】，最后英为“.” | 参考文献格式错误 | 采纳 | |
| | 正文 | 标点符号规范书写 | 文中多处标点符号不统一 | 采纳 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推广应用方案 | | 推广应用方案实施范围广泛，列出了优先推广的中医药优势重大疾病和慢性疾病，如抑郁症、慢性萎缩性胃炎等专科疾病，具有很强的可行性。如果有可能的话，建议制作系列疾病中气滞证的诊断规范短视频，有利于面向患者和社会进行中医诊断规范化科普。 | 短视频短小精悍,内容丰富,灵动有趣,具有一定的娱乐性,是当前知识传播的重要媒介，受众广泛。 | 采纳 | |